2025 AHA/ACC 고혈압 가이드라인, 미국 목표 혈압 <130/80 mmHg

미국 지침은 모든 성인 적용(국내 일반 목표 <140/90) · 130-139/80-89 mmHg
저위험군도 3-6개월 생활습관 후 약물치료 권고 — SPRINT·STEP·칼륨대체염 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

2025 가이드라인 — 무엇이 달라졌나

2017년 분류는 유지하되, 약물치료 시작 기준이 더 빨라지고 가정혈압이 더 중요해졌습니다

<130/80

미국 지침 모든 성인 목표
(국내 일반 <140/90)

46.7%

미국 성인
고혈압 유병률

3-6개월

저위험군 생활습관
후 약물치료 시작

이 수치가 뜻하는 것

핵심 변경 — 130-139/80-89 mmHg + 저위험군(10년 동맥경화성 심혈관질환 위험 <7.5%)이라도 생활습관 3-6개월 후 미개선 시 약물치료를 권고합니다.
가정혈압 측정·DASH 식이·저나트륨·고칼륨이 1차 치료의 핵심 축입니다. 5월 영향분석에 따르면 미국 성인 중 약물치료 대상자가 수백만 명 추가 확대될 전망입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline, Circulation 2025 Sept · Hypertension 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압 범위에 따라 이렇게 대처하세요

미국 지침의 진료실 혈압(2회 이상 평균) 분류 — 가정혈압은 국내 기준 135/85 이상이 고혈압

구분	위 혈압	아래 혈압	이렇게 하세요
정상	120 미만	80 미만	생활습관을 유지하고 정기적으로 측정합니다.
혈압 상승	120~129	80 미만	생활습관을 점검하고 매년 평가합니다.
1기 고혈압	130~139	80~89	위험도에 따라 생활습관 관리와 약물치료를 결정합니다.
2기 고혈압	140 이상	90 이상	생활습관 관리와 약물치료를 함께 시작합니다.
중증 고혈압	180 이상	120 이상	증상이 있으면 응급실, 증상이 없어도 신속히 외래에서 평가받습니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료실 혈압 분류 · 대한고혈압학회 2022 가정혈압 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

새 지침도 가정혈압을 핵심 근거로 봅니다 — 자세한 측정법은 가정혈압 안내문을 드립니다

정확한 가정혈압 측정법

측정 전 5분 안정 — 의자에 앉아 발 바닥에 평평히, 등 받침
아침·저녁 각 2회 — 1분 간격, 평균치 기록
커피·운동·흡연 30분 후 — 카페인·니코틴 영향 회피
팔 심장 높이 — 책상 위 팔 받침, 위팔 커프 사용
대화·휴대폰 금지 — 측정 중 침묵, 다리 꼬지 않기
※ 가정혈압 진단 기준 — 미국 2025 ≥130/80 · 국내(대한고혈압학회 2022) 1~2주 평균 ≥135/85. 국내 진료는 135/85로 판단합니다.

≥130/80 mmHg

미국 기준 (가정)

국내는 ≥135/85

2회×2 /일

측정 횟수

최소 1주 평균



그림 · 가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · AHA Statement on Home BP Monitoring 2022 · 2025 Guideline 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 치료 — 생활습관 6가지

Life's Essential 8 — 가장 강력한 단일 인자는 체중·식이·운동의 조합

DASH 식이

채소·과일·통곡물·저지방 유제품 위주. 수축기 8-14 mmHg 감소 효과 입증.

저나트륨 (소금)

하루 2,000 mg 이하(소금 5g, 세계보건기구). 한국인 평균은 3,136 mg(2023)입니다.

고칼륨 식이

하루 3,500-5,000 mg. 바나나·시금치·고구마·콩. 중국 SSaSS 연구 사망 감소 입증.

체중 감량

1 kg 감량당 수축기 1 mmHg 감소. 비만 환자 가장 큰 효과.

중강도 유산소

주 150분 (걷기·자전거·수영). 수축기 4-9 mmHg 감소.

절주·금연·수면

음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연 시 즉시 효과. 하루 7시간 수면.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 세계보건기구 나트륨 지침 2012 · 국민건강영양조사 2023 · DASH · SSaSS 칼륨대체염 RCT (N Engl J Med 2021)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 10년 동맥경화성 심혈관질환 위험 ≥7.5%가 핵심 분기점

즉시 약물치료 시작

2기 고혈압 (≥140/90) — 위험도 무관 즉시 시작 (2가지 약 병용)
1기 + 고위험군 — 동맥경화성 심혈관질환 위험 ≥7.5%, 당뇨, 만성 콩팥병, 65세+
임상적 동맥경화성 심혈관질환 — 관상동맥질환, 뇌졸중, 말초혈관질환
심부전·심장 근육이 두꺼워진 상태 — 좌심실비대 동반 시 즉시 시작
※ 1기 + 저위험군은 생활습관 3-6개월 후 재평가, 미개선 시 약물 시작.

≥7.5%

심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 10년 심혈관질환 위험
즉시 약물 기준

-27%

SPRINT 근거
엄격 강압 시 심혈관 위험

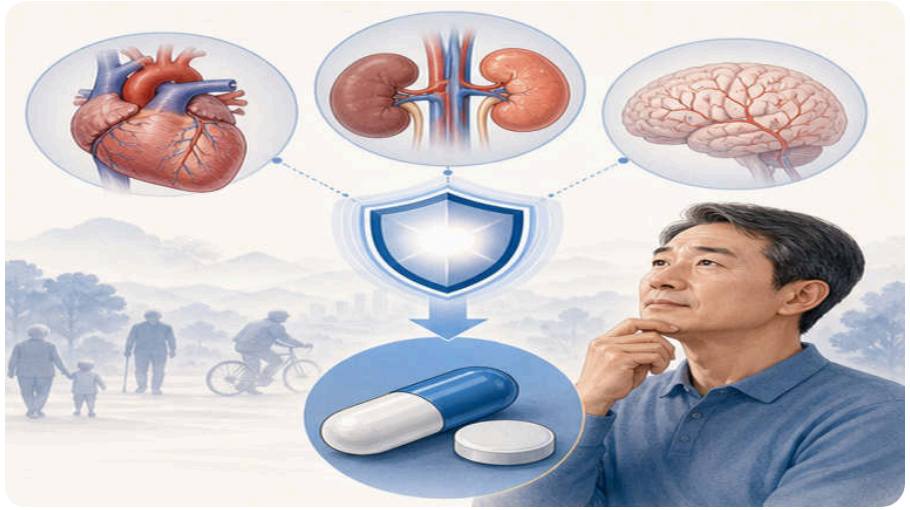


그림 · 약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · SPRINT trial (NEJM 2015) · STEP trial (NEJM 2021) · 2025 AHA/ACC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

1차 약물 4가지 계열

단일 약물보다 저용량 2가지 병용이 더 효과적·부작용 적음

안지오텐신 전환효소 억제제·안지오텐신 수용체 차단제

레닌-안지오텐신 차단. 당뇨·만성 콩팥병·심부전 동반 시 우선. 마른기침(안지오텐신 전환효소 억제제) 시 안지오텐신 수용체 차단제로 전환.

칼슘통로 차단제

암로디핀 등. 흑인·노인 효과 우월. 발 부종·잇몸증식 주의. 흉통 동반 시 우선.

티아지드 이뇨제

클로르탈리돈·인다파미드. 저렴·효과적. 혈중 칼륨·요산 모니터. 고혈압 약 비교 연구(ALLHAT) 1차 권장.

한 알에 두 성분을 담은 복합제

안지오텐신 수용체 차단제 + 칼슘통로 차단제 또는 안지오텐신 수용체 차단제 + 이뇨제. 복용 순응도↑·혈압 조절률↑. 1차 권장.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 한 알에 두 성분을 담은 복합제 임상시험 메타분석 (Lancet 2021)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단·치료 흐름 4단계

고혈압 진단부터 안정 목표 도달까지의 표준 일정

진단 시점

평가·위험도 산정 진료실 ≥2회 + 가정혈압 1주 평균. 혈액·소변·심전도·심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 위험.

1-3개월

생활습관·약물 시작 DASH 식이·운동·체중 시작. 2기·고위험은 즉시 약물. 4주 후 재평가.

3-6개월

용량 조정 목표 미달 시 용량↑ 또는 2차 약물 추가. 부작용 점검.

6개월 이후

안정 유지·연간 평가 내 목표(진료실에서 정함) 도달 후 매 3-6개월 추적. 합병증·신기능 매년.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료 흐름도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

응급 증상과 중증 혈압을 구별하세요

증상이 있으면 응급실, 증상 없이 매우 높으면 신속히 외래 진료

갑작스런 심한 두통

평소와 다른 강도, 구토 동반. 뇌출혈·고혈압성 뇌병증 가능성.

시야 흐림·복시

갑자기 한쪽 눈 시야 손상, 망막 부종 또는 망막혈관 손상 가능성.

흉통·호흡곤란

압박감 또는 쥐어짜는 통증, 식은땀 동반. 급성 관상동맥·심부전 의심.

팔·다리 한쪽 마비

말 어눌함, 안면 비대칭. 급성 뇌졸중 — FAST 원칙, 골든타임 4.5시간.

코피·요혈

압박해도 멎지 않는 코피, 소변 색 갈색·붉음. 표적 장기 손상 신호.

혈압 ≥180/120

반복 측정해도 ≥180/120이면 중증 고혈압입니다. 증상이 없으면 신속히 외래 진료를 받으세요.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC Hypertensive Emergency 정의 · 응급 가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국 진료지침과의 간극 — 적용 시 고려

KSH 2022 vs 2025 AHA/ACC — 일반 환자 목표 차이를 함께 검토

주요 차이점

일반 성인 목표 — KSH 2022 <140/90 vs AHA/ACC 2025 <130/80
고위험군 목표 — 양쪽 모두 <130/80 (일치)
1기 시작 시점 — KSH 6-12개월 후 vs AHA 3-6개월 후
한국인 특성 — 짠 음식 섭취·신부전 동반 비율 높음

참고

※ 보험 급여·약물 보험 기준은 KSH 기준 적용. 임상 판단 시 환자 위험도 + 합병증을 함께 고려해 개별화합니다.

광교바른내과 접근

고위험 · <130/80 · 당뇨·만성 콩팥병·심혈관질환 시

일반

기본 · <140/90 · 개별 위험 따라 조정

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · KSH 2022 한국 고혈압학회 진료지침 · 2025 AHA/ACC 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

환자 실천 체크리스트 7가지

진단 직후부터 시작할 수 있는 구체적 행동

01 가정혈압 매일 아침·저녁 2회씩 5분 안정 후 1분 간격 2회 측정. 평균치 기록. 진료 시 1주 기록 지참.

02 소금 줄이기 (나트륨 2,000 mg/일 이하) 국·찌개 국물 줄이기, 라면·즉석식 피하기. 영양정보 라벨 확인 습관.

03 칼륨 식품 늘리기 바나나·시금치·고구마·콩·아보카도. 신부전 환자는 제한 — 의사 확인.

04 주 150분 빠르게 걷기 하루 30분 × 5일. 식후 산책 더하면 혈압 조절·체중 모두 개선.

05 약 거르지 않기·시간 고정 매일 같은 시간 복용. 잊었을 때 12시간 이내면 바로, 이후면 다음 시간.

06 절주·금연 시작 음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연은 즉시 — 시작 1년 내 효과 큼.

07 3-6개월마다 재검 혈압·신기능·전해질·소변 알부민 추적. 합병증 매년 종합 평가.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · KSH 2022 · 광교바른내과 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 재는 법과 기록지는 가정혈압 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

참고한 자료

AHA/ACC 2025 고혈압 지침 · 대한고혈압학회 2022 지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요